

SÍNDROME DE INTESTINO IRRITABLE

María Auxiliadora Ordóñez Sánchez, Julio Zapata Alvarado, Julio Tito Camino Acha.

INTRODUCCIÓN

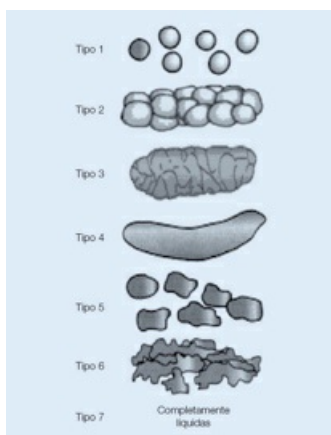
Síndrome de intestino irritable o colon irritable es un trastorno intestinal caracterizado por dolor abdominal recurrente asociado con la defecación o con un cambio del hábito intestinal, ya sea diarrea, estreñimiento o alternancia de ambos, así como hinchazón o distensión abdominal.

Los síntomas deben ocurrir al menos 6 meses antes del diagnóstico y estar presentes durante los últimos 3 meses.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico es clínico. En mayo de 2016 se publicaron los Criterios de Roma IV, que son los que actualmente se usan.

Además del cumplimiento de estos criterios, hay que excluir otras enfermedades intestinales y extraintestinales o la toma de fármacos que justifiquen los síntomas.



Escala de Bristol. Trastornos del aparato digestivo. Mascort Roca, J.J. Atención primaria. Problemas de salud en la consulta de medicina de familia, 28, 692-729.

Copyright © 2014 Elsevier España, S.L.

Adaptado de Mearin F, Ciriza C, Mínguez M, Rey E, Mascort JJ, Pena E, et al.

Clinical practice guideline: irritable bowel syndrome with constipation and functional constipation in the adult. Rev Esp Enferm Dig. 2016;108:pág 339.

Podemos subdividir el SII en varios subtipos según la consistencia de las deposiciones evaluada según la escala de Bristol. Sólo debemos tener en cuenta los días en los que las deposiciones no tienen una consistencia normal y sin que el paciente esté tomando fármacos que alteren la consistencia de las heces.

SII- E (predominio estreñimiento)	>25 % de las deposiciones corresponden a los tipos 1 o 2
SII- D (predominio diarrea).	>25 % de las deposiciones son del tipo 6 o 7.
SII con hábito deposicional mixto.	>25 % de ambas (tanto 1 o 2 como 6 o 7).
SII de hábito deposicional no clasificable.	<25% de ambas.

La exploración física es anodina, a excepción de dolor a la palpación en el marco cólico, sobre todo a nivel del sigma.

Tacto rectal. Valorar competencia del esfínter anal y detección de masas en canal anal.

En ausencia de criterios de alarma (*Tabla: Signos de alarma*), realizaremos las siguientes exámenes complementarios:

- Hemograma.
- Bioquímica con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, GOT, GPT, LDH, Bilirrubina, amilasa, PCR y VSG.
- Coagulación
- Radiografía de abdomen.
- Ecografía abdominal, si duda diagnóstica.

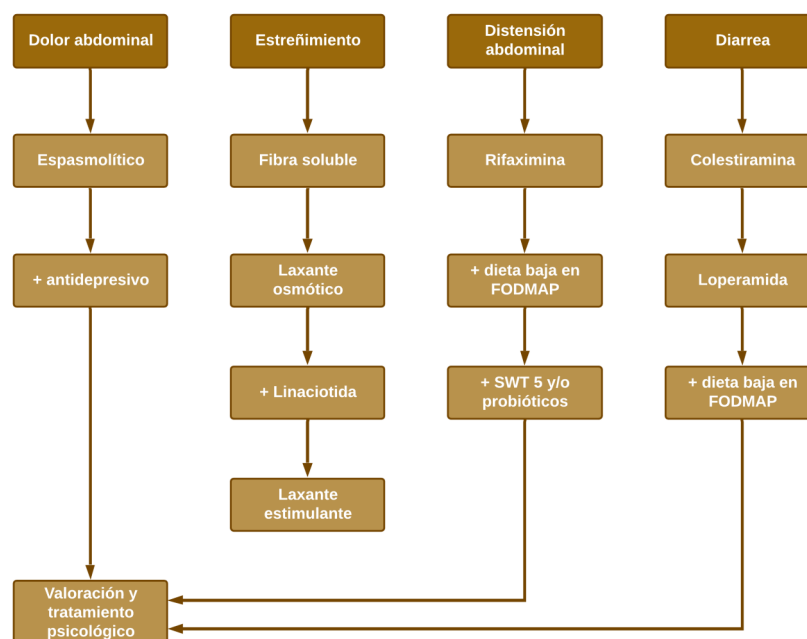
SIGNOS DE ALARMA.
Antecedentes familiares o personales de cáncer colorrectal, poliposis intestinal, enfermedad inflamatoria intestinal y enfermedad celíaca.
Inicio de los síntomas a partir de los 50 años.
Cambios recientes del ritmo deposicional habitual.
Signos y síntomas que indiquen organicidad:
Síntomas nocturnos.
Fiebre.
Anemia.
Leucocitosis.
Pérdida de peso no intencionada y no explicable por otras causas.
Sangre en las heces.
Dolor abdominal importante.
Exploración física con datos patológicos: masa abdominal palpable, visceromegalias, adenopatías, bocio o tacto rectal patológico.

TRATAMIENTO

El tratamiento dependerá de la clínica predominante y de la severidad de los síntomas.

Si los síntomas son leves, suelen ser suficientes las medidas generales: tranquilizar e informar, abstención tabáquica, consumo moderado de alcohol, ejercicio físico, una dieta equilibrada eliminando aquellos alimentos que puedan exacerbar los síntomas (sorbitol, leche grasas, cafeína) y un tiempo adecuado para la defecación.

Si los síntomas persisten a pesar de las anteriores medidas, administraremos tratamiento según el síntoma predominante.



BIBLIOGRAFÍA

- Balboa A, Rey E, Ciriza C, Mearin G, Mínguez M, Delgado-Aros S et al. Documento de actualización de la Guía de práctica clínica sobre el síndrome del intestino irritable. Madrid: IMC; 2017.
- Mearin F, Lacy BE, Chang L, Chey WD, Lembo AJ, Simren M et al. Bowel disorders. Gastroenterology. 2016;S0016-5085(16)00222-5.
- Mearin F, Ciriza C, Mínguez M, Rey E, Mascort JJ, Pena E et al. Clinical practice guideline: irritable bowel syndrome with constipation and functional constipation in the adult. Rev Esp Enferm Dig. 2016;108(6): 332-363.
- Mascort JJ, Carrillo R. Trastornos del aparato digestivo. En: Martín A, Cano F, Gené J. Atención Primaria. Problemas de salud en la consulta de medicina de familia. 7ª ed. Elsevier, Barcelona, 2014; 28: 692-729.
- Ford AC, Talley NJ. Síndrome del intestino irritable. En: Feldman M, Friedman LS, Brandt LJ. Sleisenger y Fordtran. Enfermedades digestivas y hepáticas. 10ª ed. Barcelona; Elsevier; 2018. p2139-2153.